

До прийому ендокринолога

Лада · 23.09.2026 · Мої нотатки для прийому

Чому звертаємося

Лада має **дуже сильну втому й сонливість**. Останніми днями багато спить; іноді повільніше думає та говорить, трохи плутається, буває нестійкою при ходьбі, наче злегка п'яна. За останні два тижні подібне було щонайменше двічі; наступного дня могла бути цілком нормальною. Можливо, один із попередніх епізодів був після довгого сну і без нападу астми, але точно не пам'ятаю.

Паралельно дуже погано з астмою, повторюються набряки й алергічні реакції. Майже місяць їла приблизно **100 ккал/день**; зараз близько **800-1000 ккал/день**. Раніше набрякали обличчя, руки, ноги й живіт. **Вага: 21.09 - 63,5 кг; 22.09 - 65 кг; 23.09 - 68 кг**. Зріст 170 см.

Хочу зрозуміти, яку частину цього стану можуть пояснювати гормональні проблеми, чи можуть вони впливати на перебіг алергії й астми та що потрібно перевірити й лікувати зараз.

Щитоподібна залоза: результати в різні роки

16.04.2025, Сінево: ТТГ **3,14 мкМО/мл** (норма 0,27-4,2); вільний Т4 **0,765 нг/дл** (0,92-1,68). Антитіла до ТПО 11 МО/мл (<34), до тиреоглобуліну 15,8 МО/мл (<115).

24.03.2026, Сінево: ТТГ **3,41 мкМО/мл** (0,27-4,2). Вільного Т4 у цьому аналізі немає.

19.09.2026, ДІЛА: ТТГ **5,833 мкМО/мл** (0,400-4,850); вільний Т4 **0,54 нг/дл** (0,61-1,47); вільний Т3 2,64 пг/мл (2,30-4,20). Антитіла до ТПО <0,25 МО/мл (негативні <9), до тиреоглобуліну <0,9 МО/мл (негативні <4).

Попереднє лікування

Лада пригадує, що їй говорили про **автоімунну проблему щитоподібної залози**, але висновок не знайшли й у точності цього спогаду не впевнені. Призначали Еутирокс, йод і дієту «Протокол АІТ».

Еутирокс приймала навесні 2025 року приблизно два місяці, потім припинила, бо не відчувала покращення, і більше до цього не поверталася. Дозу не пам'ятає. Не впевнені, чи аналіз 16.04.2025 був до лікування або вже під час нього.

Ендокринолог: ліки та питання

Лада · 23.09.2026

Ліки й інші результати, які можуть бути важливими

Протягом останніх тижнів неодноразово приймала **дексаметазон**, також отримувала його під час невідкладної допомоги. З 14.09 призначали **Медрол 16 мг зранку + 8 мг увечері до 20.09**; ще 22.09 казала, що приймає за призначенням. Згодом швидка порадила припинити через проблеми з животом. Потрібен зрозумілий план подальшого прийому або завершення.

Для астми призначений **Серетид Евохалер 25/125**, використовує **Беродуал**, останніми днями також **Пульмікорт**, іноді **Вентолін**. **Гленцет Едванс** приймає ввечері щонайменше кілька днів; за останньою схемою також Ніксар 20 мг зранку. Зараз не приймає гідазепам, тразодон чи Димедрол.

19.09: гемоглобін 112 г/л, MCV 78,9 фл; натрій 140, калій 4,06, магній 0,76, фосфор 1,43, кальцій загальний 2,31, глюкоза 5,6 ммоль/л; креатинін 66 мкмоль/л, альбумін 36 г/л.

14.09: феритин 31,5 нг/мл, насичення трансферину залізом 9,05%. **24.03.2026:** вітамін D 15,8 нг/мл, глюкоза 5 ммоль/л. Ці результати отримані в різні дні, не під час кожного епізоду сонливості.

Що хочу з'ясувати сьогодні

1. Як пояснити результати щитоподібної залози? Вільний T4 був зниженим і у 2025 році при нормальному ТТГ, і зараз при підвищеному ТТГ. Чи потрібні повторні ТТГ та вільний T4, коли їх краще здати з урахуванням нинішнього стану, харчування й стероїдів? Чи потрібні інші гормональні обстеження, а не лише ТТГ?

2. Чи потрібне лікування вже зараз? Якщо потрібен Еутирокс або інше лікування, прошу вказати конкретну схему, час прийому щодо їжі й інших ліків, строк контролю аналізів та очікуваний час покращення. Чи є підстави вважати проблему автоімунною?

3. Як оцінити сонливість, слабкість і вплив стероїдів? Прошу оцінити, чи можуть це пояснювати гормони, чи потрібна сьогодні інша перевірка. Чи потрібно перевіряти роботу наднирників після повторних курсів; якщо так, коли й як це зробити, щоб прийом стероїдів не спотворив результат? Як безпечно завершити їх з урахуванням лікування астми?

4. Чи пов'язані ці зміни з набряками, алергією та астмою? Хочу зрозуміти, що може покращитися від лікування гормональної проблеми, що потребує окремої оцінки та які додаткові аналізи справді потрібні з огляду на недостатнє харчування, гемоглобін і залізо.